



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : علياء عاطف يماني سالم
المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : بنها
رقم البطاقة : 28609141402927 رقم التليفون : 01226241715
العنوان :
العمر (تاريخ الميلاد) : 14-09-1986 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمدة 6 شهور
قسم العلاج :
الأورام

[14163]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: علياء عاطف يمانى سالم National ID: 28609141402927	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Patient Name: Aliaa Atef Yamani Salem Mohamed Diab	Date: 19/07/2022
Exam: MAMMOGRAPHY BOTH	Age: 35 Year(s)
Medical ID: 2735/2022	Pat. ID: 15349

**DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Indication:

Right breast pathologically proven malignant mass

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- ACR b: scattered fibroglandular parenchyma
- Right Breast:
 - Ill-defined spiculated high density lesion and surrounding parenchymal distortion is seen in the right UOQ with overlying malignant microcalcifications are seen over an area measuring about 12x12x9cm. By U/S an irregular invasive hypoechoic mass with spiculated outline is seen in the retro-areola region reaching the nipple and causing retraction and ulceration.
 - Diffuse skin thickening and mild edema pattern
 - Pathological enlarged level I axillary LN largest measures 14mm and 7mm cortical thickness.
 - No pathological enlarged internal mammary or supraclavicular lymph nodes.
- Left Breast:
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Right breast locally advanced malignant mass with ipsilateral level I axillary lymphadenopathy (BIRADS 6)
- Normal sonomammography of left breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Amira H Radwan MD

19/7/2022



Patient Name: Aliaa Atef Yamani Salem Mohamed Diab	Date : 30/09/2023
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 37 Year(s)
Medical ID: 2735/2022	Pat. ID: 15349

LEFT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had right MRM.

Technique

- left breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The left breast is scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no left breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No left breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Dr. Wafaa Ali



Patient Name: Aliaa Atef Yamani Salem Mohamed Diab	Date : 03/03/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 38 Year(s)
Medical ID: 2735/2022	Pat. ID: 15349

NON ENHANCED MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Chest:

***** As Compared to last study dated on 1/10/2024 shows:***

- Evidence of right MRM with no underlying suspicious lesions on non-contrast bases.
- Still noted Middle lobe lateral segment subpleural area of consolidation with atelectasis also seen, likely post radiation sequel.
- Still noted Diffuse mosaic attenuation of both lung fields predominant lower lobar with areas of ground glass attenuation intermingled with areas of low densities? air trapping/ areas of emphysema.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

1. Upper abdominal cuts was unremarkable.

2. The scanned skeleton:

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- ***Evidence of right MRM.***
- ***Middle lobar area of consolidation and atelectatic changes likely post radiation sequel.***
- ***No definite hepatic or osseous metastatic deposits on non-contrast basis***

✓ Dr. Mohamed Sayed

Dr. Walid Mohamed, M.D.



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m3339

Female	النوع	علايا عاطف يماني	المريض
بنها	العنوان	36 Y	سن
04/07/2022 12:47	تاريخ استلام العينة	مستشفى بنها التعليمي	يخ أخذ العينة
07/07/2022 10:08	تاريخ التقرير	مستشفى بنها التعليمي	ب التحليل

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample recieved was treated by: - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody.- CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample recieved was treated by: - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.
Sample recieved was treated by: - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: moderate nuclear staining of 50 % of tumour cells
PR: moderate nuclear staining of 10 % of tumour cells
HER2/neu protein over expression : strong continuous membrane staining of > 10 % of tumor cells.
Ki67: positive nuclear staining of 10-15 % of tumour cells

Referral Lab :

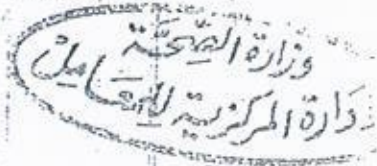
Comment :

Conclusion :

ER: POSITIVE (SCORE 6/8)
PR: POSITIVE (SCORE 4/8)
HER2/NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : POSITIVE (SCORE 3+)
#Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 10-15 %
(CORE BIOPSY)

Pathologist:

د/أيناس رمزي



Lab Director: د/تريزا ماهر



19 El-sheikh Rehan Street, Abeideen, Cairo
Tel.(165)7948544 -7950096 Fax. (202)7948544
Mobile . 01144297292
website: http://www.healthlabs.net
email: pathologychl@yahoo.com
facebook: قسم الباثولوجي - الادارة المركزية للمعمل

This Test Is Not Accredited EGAC Nor Recognized By ILA

يتم الاحتفاظ بأصل العينة لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها



Patient Name : الأستاذ / علياء عاطف يمتنى سالم	Request No. : 13008092
Patient No. : 28609141402927	Request Date : 20/12/2022
Path No. : 3828/22	Verification Date : 07/01/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 36 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer post NACT.
Nature of the specimen: Right Modified radical mastectomy

Gross Examination:

- Procedure: Right MRM
- measured 34x24x10 cm with covering skin ellipse measured 21x12 cm.
- Tumor extent: An ill defined greyish white firm mass measured 6x5.5x3 cm.
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- Distance from margins: 3 cm away from deep margin.
- Lymph nodes number and size: 9 L.Ns up to 0.5x1 cm.

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma (Actual tumor size 0.5 cm, Cellularity 10%)
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II (3+2+1)
- Ductal carcinoma in situ: Focal.
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free L.Ns (0/9)
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:

- Right MRM (post NACT):
Invasive duct carcinoma grade II (Actual tumor size 0.5cm, Cellularity 10%)
- Free margins
 - Free nipple and areola
 - Free L.Ns (0/9)
 - Pathologic partial response
 - Stage: ypT1N0

Verified by :

Dr.Marwa mahmoud

Patient Name : الأستاذة / علياء عاطف يمثنى سالم	Request No. : 13008092
Patient No. : 28609141402927	Request Date : 20/12/2022
Path No. : 3828/22	Verification Date : 07/01/2023
Sex : Female	Financial Category : نفقة الدولة - اورام دار السلام
Age : 36 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

• RCB:1.868 , RCB classII

Prof. Dr. Iman Gouda

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 07/01/2023 12:01:07

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



A-Patient ID:

1- Name : عطاء عاطف يماني سالم

Sex:

MDT form

3- Medical number:
Female

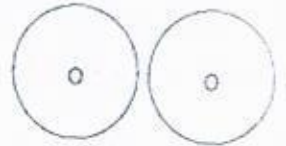
83084824

Old Med :

2735/2022

2-ID number: 28609141402927

Patient Age : 36 Y



Family history

-VE

Phone

0122233175

BMI

29

REASON OF MDT

marital status

NRS Score

II

GROUP

Co morbidity

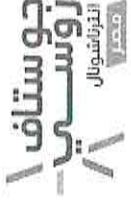
Menopausal
status

Date of MDT

01/22/2023

Breast Imaging :			Clinical data		
BX:			Mets Workup :		
AND LOBULAR FEATURES 7/22			CTCAP7/22-->FREE,,,BONE SCAN7/22-->FREE		
ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	Ki67 :	
				10-15	
T	N	M			
4B	1	0			
Sonomammography					
7/22-->RT LABC AT UOQ WITH MICROCALCIFICATIONS 12X12X9 CM WITH RETRACTION AND NIPPLE ULCERATION,,DIFFUSE SKIN THICKENING AND MILD EDEMA+ IPSILATRAL PLN BIRADS 6					
PATIENT HISTORY					
The patient received neoadj TCHP x 6					
PATHOLOGY REPORT 20/12/2022--> RT MRM POST NACT (TCX6HPX4):					
IDC GII,,FREE MARGINS,,FREE NIPPLE AND AREOLA,,FREE LNS 0/9,,PPR					
STAGE YPT1N0,,RCB 1.868,RCB CLASS II					
MDT OUTCOME & PLAN					
FOR POST-OP RTH, ZOLADEX AND AI, TDM1 FOR 12 CYCLES					
MEDICAL ONCOLOGY		SIGNATURE		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY		Nutrition	
Psychiatric					

Medical No. : 9434
Patient's Name: Alaia Atif Yamani Salem
Date: 2026-09-22
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Enlarged sized (18cm at Rt MCL) homogenous bright parenchymal echo pattern . Multiple hepatic focal lesions, solid and hypoechoic; the largest at segment 4b measuring 1x1 cm.
- No IHBRD seen
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

Distended size, no stones and no masses and no mud with normal wall thickness. Patent CBD and not dilated.

Spleen: -

- Average size 12 cm, homogenous texture with no focal lesions

Kidneys: -

- Both kidneys of normal size, shape, normal echogenicity and well differentiated with good corticomedullary differentiation.
- No stones , no back pressure changes

Para-aortic and pancreatic area: homogenous with no masses or cystic lesions.

Urinary Bladder: -

- No stones or Masses.

Uterus and adnexae: -

- No gross uterine or adnexal masses.

No ascites or free fluid.

Opinion:

Fatty hepatomegaly with multiple focal lesions likely metastatic for Triphasic CT abdomen and pelvis.

Dr. Dalia Adel

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

بشأن تقرير طبي للمريض: علياء عاطف يعانى

إيماء للطلب المقدم من

يقسم. رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول

تاريخ وساعة الخروج

ويعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

Breast Cancer for

MRI liver with

Contrast → Suspected

HFL metastatic by AUS

multiple, largest 1cm

تحريراً في

التاريخ: / /

الوقت:

الطبيب المعالج

يعتمد،،

٢٠١٦/١٢/٠٥

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/.....

تحية طبية وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض: علاء عاصف عباس

بقسم رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

علاء عباس
الطالبة
for
Breast Cancer
CT Chest, abdomen, pelvis
with Contrast with Comparison

تحريراً في

الوقت: التاريخ: / /

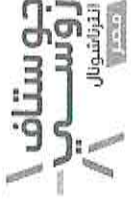
الطبيب المعالج

.....

يعتمد،،

2016/12

Medical No. : 9434
Patient's Name: Alaia Atif Yamani Salem
Date: 2026-09-22
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Enlarged sized (18cm at Rt MCL) homogenous bright parenchymal echo pattern . Multiple hepatic focal lesions, solid and hypoechoic; the largest at segment 4b measuring 1x1 cm.
- No IHBRD seen
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

Distended size, no stones and no masses and no mud with normal wall thickness.
Patent CBD and not dilated.

Spleen: -

- Average size 12 cm, homogenous texture with no focal lesions

Kidneys: -

- Both kidneys of normal size, shape, normal echogenicity and well differentiated with good corticomedullary differentiation.
- No stones , no back pressure changes

Para-aortic and pancreatic area: homogenous with no masses or cystic lesions.

Urinary Bladder: -

- No stones or Masses.

Uterus and adnexae: -

- No gross uterine or adnexal masses.

No ascites or free fluid.

Opinion:

Fatty hepatomegaly with multiple focal lesions likely metastatic for Triphasic CT abdomen and pelvis.

Dr. Dalia Adel

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تحية طيبة وبعد،،

بشأن تقرير طبي للمريض: علياء عاطف يعانى

إيماء للطلب المقدم من

يقسم. رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول

تاريخ وساعة الخروج

ويعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

Breast Cancer for

MRI liver with

Contrast → Suspected

HFL metastatic by AUS

multiple, largest 1cm

تحريراً في

التاريخ: / /

الوقت:

الطبيب المعالج

يعتمد،،

٢٠١٦/١٢/٠٥

اسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/.....

تحية طبية وبعد،،

إيماء للطلب المقدم من بشأن تقرير طبي للمريض: علاء عاصف عباس

بقسم رقم طبي

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الدخول تاريخ وساعة الخروج

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه:

علاء عباس
الطالبة
for
Breast Cancer
CT Chest, abdomen, pelvis
with Contrast with Comparison

تحريراً في

الوقت: التاريخ: / /

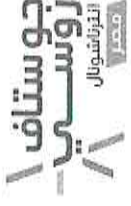
الطبيب المعالج

.....

يعتمد،،

2016/12

Medical No. : 9434
Patient's Name: Alaia Atif Yamani Salem
Date: 2026-09-22
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Enlarged sized (18cm at Rt MCL) homogenous bright parenchymal echo pattern . Multiple hepatic focal lesions, solid and hypoechoic; the largest at segment 4b measuring 1x1 cm.
- No IHBRD seen
- Portal vein is patent and not dilated.

Gall Bladder: -

Distended size, no stones and no masses and no mud with normal wall thickness.
Patent CBD and not dilated.

Spleen: -

- Average size 12 cm, homogenous texture with no focal lesions

Kidneys: -

- Both kidneys of normal size, shape, normal echogenicity and well differentiated with good corticomedullary differentiation.
- No stones , no back pressure changes

Para-aortic and pancreatic area: homogenous with no masses or cystic lesions.

Urinary Bladder: -

- No stones or Masses.

Uterus and adnexae: -

- No gross uterine or adnexal masses.

No ascites or free fluid.

Opinion:

Fatty hepatomegaly with multiple focal lesions likely metastatic for Triphasic CT abdomen and pelvis.

Dr. Dalia Adel